

MODUL PRAKTIKUM PENATALAKSANAAN PENYAKIT GIGI DAN MULUT



Dosen Pengampu :

1. Nasri, S.SiT, M.Pd
2. Drg. Cut Ratna Keumala, MKM
3. Herry Imran, SKM, M.Pd
4. Henny Febriani, S.S.T, MDSc

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH
PRODI TERAPI GIGI PROGRAM SARJANA TERAPAN
JURUSAN KESEHATAN GIGI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Buku Penuntun Praktikum Pelaksanaan Penyakit Gigi dan Mulut
untuk Mahasiswa Jurusan Kesehatan gigi
Poltekkes Kemenkes Aceh

Telah disetujui dan disahkan penggunaannya sebagai penuntun praktikum
Penatalaksanaan Penyakit Gigi dan Mulut
bagi mahasiswa Jurusan Kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Aceh

Aceh Besar, Agustus 2024
Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan
Ketua,

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan gigi
Ketua,

Reca, S.S.T, M.Kes
NIP. 198307082005012001

Nurdin, S.SiT, MDSc
NIP. 197105181994031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi begitu banyak nikmat dan karunia-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan Buku Modul Ajar Penatalaksanaan Penyakit Gigi dan Mulut bagi mahasiswa Jurusan Kesehatan gigi Politeknik Kesehatan Aceh.

Buku ajar ini disusun sesuai dengan materi kuliah Kesehatan gigi dan Mulut bagi mahasiswa Jurusan Kesehatan gigi. Penyusun berharap buku ajar ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Jurusan Kesehatan gigi dalam melakukan Pemeriksaan Kesehatan gigi dan Mulut.

Buku ini terbit atas kerjasama tim penyusun yang terdiri dari dosen-dosen mata kuliah Kesehatan gigi dan Mulut dari beberapa Jurusan Kesehatan gigi Politeknik Kesehatan, yang difasilitasi oleh Forum Komunikasi Jurusan Kesehatan gigi dan para Ketua Jurusan Kesehatan gigi Politeknik Kesehatan se-Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ajar ini belumlah sempurna, walaupun demikian kami berharap semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, Agustus 2024
Penyusun,

Nasri, S.SiT, M.Pd

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PEMBAHASAN TEKNIK/CARA PEMERIKSAAN SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF	1
A. Pemeriksaan Subyektif.....	1
B. Pemeriksaan Objektif.....	4
C. Macam – macam cara pemeriksaan objektif.....	5
D. Kartu Status.....	13
BAB II KELAINAN ANOMALI GIGI.....	15
A. Pengertian kelainan /anomali Gigi	15
B. Faktor – faktor penyebab.....	15
C. Anomali berdasarkan jumlah.....	15
D. Anomali gigi berdasarkan bentuk.....	16
E. Anomali berdasarkan ukuran.....	18
F. Anomali posisi gigi.....	18
G. Anomali struktur gigi	19
H. Anomali erupsi	19
BAB III KELAINAN JARINGAN KERAS GIGI DAN JARINGAN PULPA	20
A. Kelainan jaringan keras gigi dan jaringan pulpa	20
B. Kelainan jaringan keras gigi	20
C. Kelainan jaringan pulpa.....	25
BAB IV PENYAKIT / KELAINAN PADA JARINGAN PENYANGGA GIGI DAN JARINGAN LUNAK MULUT	29
A. Pengertian jaringan penyangga gigi	29
B. Jaringan penyangga gigi terdiri dari	29
1. Gingiva	29
2. Periodontal membran	30

3. Sementum	30
4. Prosesus alveolaris / Tulang Alveolar.....	30
C. Penyakit jaringan penyangga gigi.....	31
D. Penyakit jaringan penyangga gigi.....	31

BAB V PENYAKIT – PENYAKIT SISTEMIK YANG BERMANIFESTASI DALAM MULUT 40

a. Gangguan Hormonal.....	40
b. Kelainan darah	41

BAB VI PENYAKIT – PENYAKIT YANG DISEBABKAN INFEKSI DARI GIGI / FOCAL INFECTION 42

BAB VII PEDOMAN PRAKTIKUM 44

1. Tujuan Praktikum.....	45
2. Sistem penilaian	45
3. Tata tertib praktikum.....	46
4. Saksi.....	45
5. Alat – alat dan bahan yang harus disediakan oleh mahasiswa.....	45
6. Prosedur kerja praktek ilmu kesehatan gigi	45
7. Minimal Requirement	46

EVALUASI 47

DAFTAR PUSTAKA 48

BAB I
MANTERI I
TEHNIK / CARA PEMERIKSAAN SUBYEKTIF DAN OBYEKTI

A. PEMERIKSAAN SUBYEKTIF

Pemeriksaan Subyektif adalah pemeriksaan berdasarkan atas keluhan penderita. Untuk memperoleh suatu riwayat dalam bentuk wawancara, maka hendaklah pemeriksa dan penderita mempunyai kesamaan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah yang mudah dan sederhana sehingga dapat dimengerti oleh penderita. Pemeriksa harus dapat mengembangkan suatu situasi guna perekaman wawancara dengan baik. Jika penderitanya adalah anak kecil, maka harus didapat kepercayaan anak tersebut terhadap pemeriksa. Pemeriksa seakan-akan ikut merasakan hal-hal yang diderita pasien dan memberi kesempatan penderita mengemukakan keluhan-keluhannya. Kadang-kadang dalam melakukan wawancara dengan anak kecil sulit dilakukan, sehingga pemeriksa perlu melakukan wawancara dengan salah satu keluarganya. Keadaan ini disebut *allo anamnesis*. Bila wawancara dilakukan terhadap penderita sendiri, keadaan ini disebut *auto anamnesis*.

1. CARA PENGAMBILAN RIWAYAT (ANAMNESIS)

a. CHIEF COMPLAINT (KELUHAN UTAMA)

Chief Complaint atau keluhan utama adalah alasan pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Umumnya, suatu keluhan utama berhubungan dengan rasa sakit, pembengkakan, tidak berfungsi/estetik. Adapun alasannya, keluhan utama pasien merupakan titik permulaan yang terbaik untuk mendapatkan suatu diagnosis yang tepat. Pada *Chief Complaint* ini biasanya ditanyakan tentang penyakit yang diderita dan lokasinya.

b. PRESENT ILLNESS (RIWAYAT PENYAKIT SEKARANG)

Yang dimaksud dengan *Present Illness* adalah kronologis dari keluhan utama yang berhubungan dengan gejala-gejala, mulai sejak timbulnya sampai pada waktu riwayat ini dicatat oleh pemeriksa. Pertanyaan yang diajukan harus dipilih sehingga memperoleh jawaban yang relevan (berkaitan erat dengan keluhan utama). Pada

Present Illness ini biasanya ditanyakan kapan mulai sakit, bagaimana rasa sakitnya (linu, sakit berdenyut, dll), bagaimana jika untuk minum dingin/ tidur/ mengunyah dll, dan sekarang bagaimana (sakit tidak)

c. *PRESENT ILLNESS (RIWAYAT PENYAKIT SEKARANG)*

Yang dimaksud dengan *Present Illness* adalah kronologis dari keluhan utama yang berhubungan dengan gejala-gejala, mulai sejak timbulnya sampai pada waktu riwayat ini dicatat oleh pemeriksa. Pertanyaan yang diajukan harus dipilih sehingga memperoleh jawaban yang relevan (berkaitan erat dengan keluhan utama).

Pada *Present Illness* ini biasanya ditanyakan kapan mulai sakit, bagaimana rasa sakitnya (linu, sakit berdenyut, dll), bagaimana jika untuk minum dingin/ tidur/ mengunyah dll, dan sekarang bagaimana (sakit tidak).

d. *PAST HISTORY (RIWAYAT PENYAKIT DAHULU)*

Terdiri atas 2 bagian :

- 1) *Past Dental History (PDH)*
- 2) *Past Medical History (PMH)*

Pasien ditanya apakah pernah memeriksakan giginya, apakah ada komplikasi pada waktu pencabutan. Hal ini dapat memberikan ramalan-ramalan penyembuhan atau tindakan yang akan diberikan dan ini sangat berharga untuk informasi diagnostik. Yang perlu diingat mengenai perawatan masa lampau, jangan diarahkan bahwa penderita merupakan korban dari yang merawat masa lampau. Untuk *PMH* ditanyakan mengenai riwayat penyakit yang pernah/sedang diderita, misal penyakit jantung, diabetes mellitus, hepatitis, alergi dll.

e. *FAMILY HISTORY (FH)*

Harus ditanyakan keadaan kesehatan umum keluarga adalah apakah ada riwayat penyakit mental, sebab-sebab kematian dari orang tua, riwayat penyakit sistemik keluarga, riwayat masalah-masalah gigi keluarga.

f. *PERSONAL & SOCIAL HISTORY*

Ditanyakan mengenai status perkawinan, kesehatan dari pasangannya, mengandung/ tidak. Ditanyakan juga kebiasaan-kebiasaan buruk penderita terutama yang berhubungan dengan kondisi giginya.

Secara sederhana 6 prinsip anamnesis yang baik adalah 5 W + 1 H :

- | | |
|----------------|-----------------|
| <i>a. Who</i> | <i>d. Where</i> |
| <i>b. What</i> | <i>e. Why</i> |
| <i>c. When</i> | <i>f. How</i> |

2. DAFTAR PERTANYAAN ANAMNESIS :

a. KHUSUS (mengenai keadaan gigi)

- 1) Tujuan datang ke klinik ?
- 2) Bagaimana sakitnya ?
- 3) Bagian mana yang sakit ?
- 4) Kapan mulai sakit ?
- 5) Sebelumnya pernah sakit/tidak ?
- 6) Sekarang masih sakit/tidak ?

b. UMUM (mengenai riwayat penyakit)

- 1) Apakah anda dalam keadaan sehat ?
- 2) Apakah anda sedang dalam perawatan dokter ?
- 3) Apakah anda sedang dalam masa pengobatan ? Mohon dilingkari penyakit yang anda alami : Jantung, hipertensi, TBC, diabetes, asma, hepatitis, alergi.
- 4) Pernahkah anda mengalami pendarahan yang berkepanjangan sesudah operasi ?
- 5) Pernahkah anda mengalami sesuatu yang diluar kebiasaan terhadap obat panti rasa atau obat (misalnya penisilin) ?
- 6) Apakah ada informasi lain yang perlu diketahui mengenai kesehatan anda ?

Tujuan pemeriksaan subyektif adalah untuk membantu menegakkan diagnosa, contoh :

1. Rasa sakit yang mungkin dijelaskan dengan menetap, sangat sakit pada waktu malam, lebih sakit sesudah makan atau gigi peka terhadap panas/ dingin dapat membantu menetapkan diagnosis dengan menunjukkan apakah itu berasal dari inflamasi jaringan pulpa atau jaringan periapikal.
2. Lama rasa sakit, sakit yang hanya dirasakan pada waktu gigi dirangsang biasanya menunjukkan pulpitis reversibel. Sakit yang terus menerus menunjukkan pulpa yang ireversibel.

B. PEMERIKSAAN OBYEKTIF

Pemeriksaan obyektif adalah pemeriksaan yang dilakukan operator pada obyek dengan keadaan-keadaan sebagaimana adanya, tidak ada pengaruh perasaan. Tujuan pemeriksaan obyektif adalah untuk mengidentifikasi kelainan yang ada pada gigi dan mulut.

Pemeriksaan Obyektif terdiri dari :

1. PEMERIKSAAN EKSTRA ORAL

Pemeriksaan dari bagian tubuh penderita di luar mulut yaitu pada daerah muka, kepala, leher.

Cara pemeriksaan ekstra oral :

- a. Membandingkan sisi muka penderita sebelah kiri dengan sebelah kanan, simetris atau tidak.
- b. Memeriksa pembengkakan dengan palpasi atau meraba, yaitu meraba kelenjar, misalnya kelenjar submandibula yaitu dengan cara penderita duduk pada posisi tegak, pandangan mata ke depan posisi operator di belakang pasien. Dalam keadaan normal akan teraba lunak dan tidak sakit, kadang-kadang tidak teraba. Bila terdapat peradangan akut, maka kelenjar akan teraba lunak dan sakit. Jika teraba keras dan tidak sakit berarti ada peradangan khronis, tetapi bila teraba keras dan sakit berarti ada peradangan khronis eksaserbasi akut.
- c. Meraba pada daerah pembengkakan dengan menggunakan punggung tangan, untuk mengetahui suhu di daerah pembengkakan tersebut.

2. PEMERIKSAAN INTRA ORAL

Pemeriksaan intra oral yaitu pemeriksaan dari bagian rongga mulut yang meliputi mukosa dan gigi. Pemeriksaan intra oral dilakukan dengan cara memeriksa keadaan mulut secara menyeluruh untuk melihat kelainan mukosa dari pipi, bibir, lidah, palatum, gusi dan gigi. Cara pemeriksaan gigi geligi dimulai dari kwadran kanan atas kemudian kiri atas, kiribawah dan terakhir kwadran kanan bawah.

Kode kwadran untuk gigi tetap sebagai berikut : Kwadran 1 ; Kwadran kanan atas

Kwadran 2 ; kwadran kiri atas

Kwadran 3 ; kwadran kiri bawah

Kwadrant 4 ; kwadrant kanan bawah

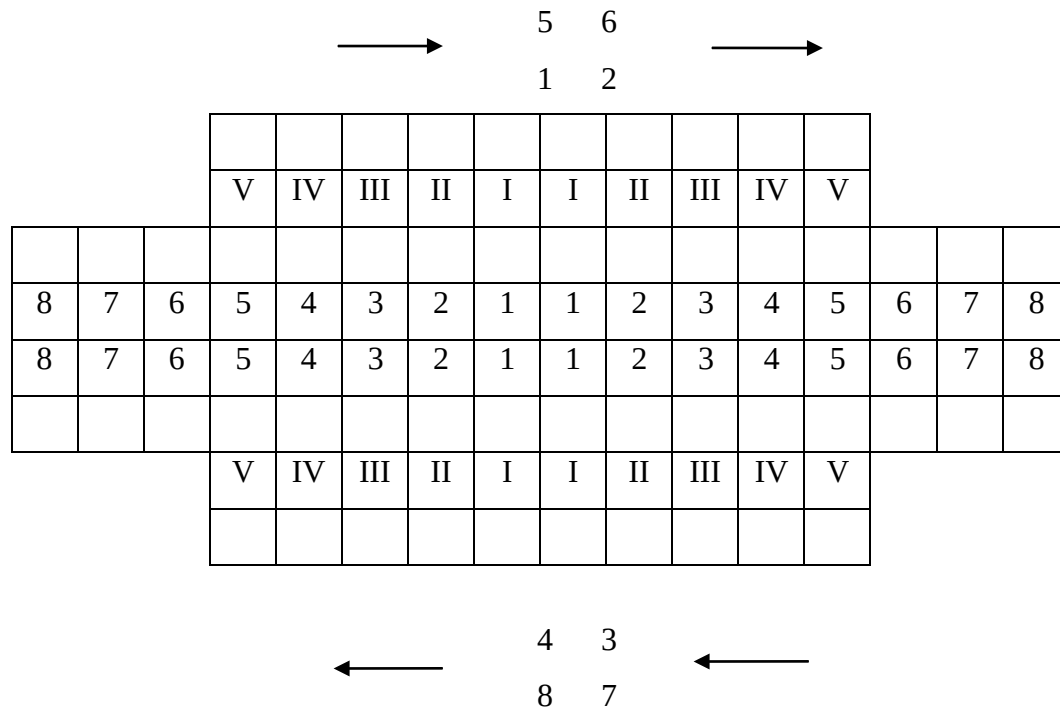
Kode kwadrant untuk gigi susu sebagai berikut : Kwadrant 5 ; kwadrant kanan atas

Kwadrant 6 ; kwadrant kiri atas

Kwadrant 7 ; kwadrant kiri bawah

Kwadrant 8 ; kwadrant kanan bawah

Alur Pemeriksaan Gigi-geligi :



Gambar 1 : Alur pemeriksaan gigi geligi

C. MACAM-MACAM CARA PEMERIKSAAN OBYEKTIF

1. Inspeksi
2. Probing / Sondasi
3. Termis
4. Perkusi
5. Tekanan
6. Tes Mobilitas
7. Membau
8. Palpasi
9. Tes Vitalitas
10. Rontgen Foto
11. Tes Anestetik
12. Tes Kavitas

1. INSPEKSI

Uji klinis yang paling sederhana adalah pemeriksaan berdasarkan penglihatan. Pemeriksa menggunakan mata, kaca mulut. Gigi geligi harus diperiksa di bawah sinar terang dan

dalam keadaan kering. Pemeriksaan inspeksi ini sering dilakukan sambil lalu sehingga banyak informasi penting hilang. Suatu pemeriksaan inspeksi pada jaringan keras dan lunak yang cermat mengandalkan pada pemeriksaan “*three Cs*” : *colour*, *contour* dan *consistency* (warna, kontur dan konsistensi). Pada jaringan lunak, seperti gusi, penyimpangan dari warna merah muda dapat dengan mudah dikenal bila terdapat inflamasi.

2. PROBING/ SONDASI

Sisa makanan yang tinggal dalam lubang karies harus dibersihkan dengan ekskavator. Kadang-kadang ada juga hal yang meragukan misalnya dari permukaan oklusal terlihat karies kecil, tetapi dengan pemeriksaan dengan sonde dapat dirasakan kariesnya sudah dalam. Pemeriksaan dengan sonde harus dilakukan tanpa tekanan.

Guna pemeriksaan dengan sonde untuk mengetahui :

a. Ada karies atau tidak

Bila akan memeriksa adanya karies, sonde digoreskan pada gigi, bila sonde tersangkut berarti ada karies.

b. Kedalaman karies

Karies superfisialis (karies email) yaitu karies yang belum sampai dentin baru sampai *dentino enamel junction*. Karies superfisialis tidak memberi keluhan, kecuali bila sudah sampai *dentino enamel junction*.

c. Ada reaksi dari pulpa atau tidak

Sonde digoreskan pada dasar kavita tanpa tekanan, harus hati-hati jangan sampai terjadi perforasi. Bila ada keluhan sakit berarti gigi vital. Bila tidak ada keluhan sama sekali berarti non vital.

d. Ada perforasi atau tidak

Bila dilakukan sondasi dan sonde masuk ke dalam ruang pulpa berarti sudah perforasi.

3. TERMIS

Tes ini meliputi aplikasi dingin dan panas pada gigi, untuk menentukan sensitivitas terhadap perubahan termal. Meskipun keduanya merupakan tes sensitivitas, tetapi tidak sama dan digunakan untuk alasan diagnostik yang berbeda. Suatu respon terhadap dingin menunjukkan pulpa vital, tanpa memperhatikan apakah pulpa itu normal atau abnormal. Suatu respon abnormal terhadap panas biasanya menunjukkan adanya gangguan pulpa atau periapikal yang memerlukan perawatan endodontik.

Cara pemeriksaan Termis :

Pada pemeriksaan dengan termis dingin maupun pemeriksaan dengan termis panas, yang harus dilakukan adalah gigi dibersihkan dari sisa-sisa makanan dan dikeringkan.

a. Cara pemeriksaan dengan termis dingin

Setelah gigi dibersihkan dan dikeringkan, ambil kapas kecil dengan pinset, kemudian semprotkan klor etil pada kapas tersebut. Sesudah berbuih (kristal putih), kapas tersebut diletakkan pada dasar kavita gigi. Bisa juga digunakan air es sebagai pengganti klor etil.

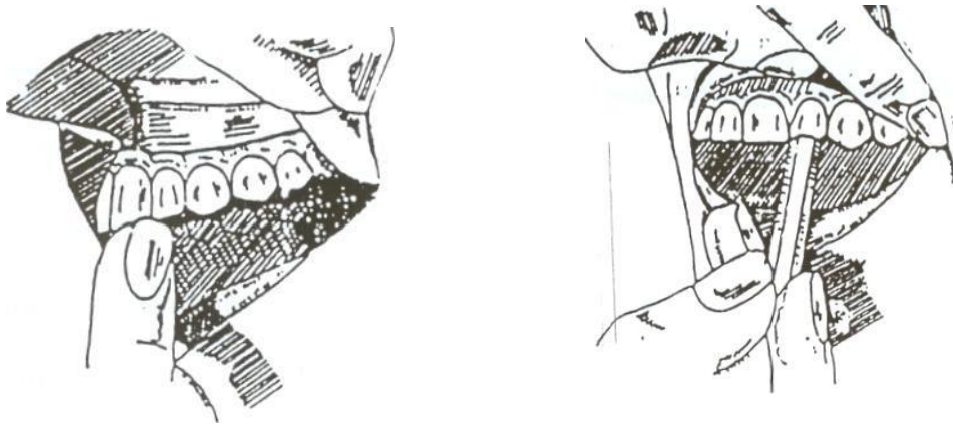
b. Cara pemeriksaan dengan termis panas

Tes panas dapat dilakukan dengan menggunakan cara yang berbeda-beda yang menghasilkan derajat temperatur yang berbeda. Daerah yang akan dites diisolasi dan dikeringkan, kemudian udara hangat dari semprotan angin/*chip blower* dikenakan pada permukaan gigi dan respon pasien dicatat. Dari pemeriksaan dengan termis dapat diperoleh diagnosis sementara, misalnya :

- 1) Pemeriksaan dengan termis dingin positif, berarti gigi tersebut vital, berarti gigi tersebut dapat didiagnosis sementara :
 - a) Iritasi Pulpa
 - b) Hiperemi Pulpa
 - c) Pulpitis Partialis Akut/ Pulpitis Totalis Akut
 - d) Pulpitis Kronis
- 2) Pemeriksaan dengan termis panas positif, berarti gigi tersebut dapat didiagnosis sementara :
 - a) Pulpitis
 - b) Nekrosis
 - c) Abses

4. PERKUSI

Uji ini dapat digunakan untuk menentukan adanya peradangan pada jaringan penyangga gigi. Gigi diberi ketukan cepat dan tidak keras, mula-mula dengan jari dengan intensitas rendah, kemudian intensitas ditingkatkan dengan menggunakan tangkai instrument, untuk menentukan apakah gigi terasa sakit. Suatu respon sensitif yang berbeda dari gigi di sebelahnya, biasanya menunjukkan adanya periodontitis.



Gambar 2 : Cara melakukan perkusi

5. TEKanan/ DRUK

Prosedur pemeriksaan dengan tekanan : menyiapkan alat (tangkai instrumen) yang dibungkus isolator karet, kain kasa atau kapas.

Caranya :

Pegang tangkai instrumen, ditekankan pada gigi yang memberikan keluhan. Bisa juga penderita disuruh menggigit tangkai instrumen yang sudah dibungkus/membuka menutup mulut sehingga gigi beroklusi atas bawah. Bila memberikan reaksi berarti sudah terjadi periodontitis. Kegunaan pemeriksaan dengan tekanan selain untuk mengetahui kelainan pada jaringan penyangga gigi juga untuk mengetahui adanya keretakan gigi.

Gambar 3 : Cara melakukan tekanan/druk



6. TES MOBILITAS

Tes mobilitas ialah pemeriksaan dengan menggerakkan gigi ke arah lateral (menggoyangkan gigi). Tujuan tes ini adalah untuk menentukan apakah gigi terikat kuat atau longgar pada alveolusnya. Jumlah gerakan menunjukkan kondisi periodontium; makin besar gerakannya, makin jelek status periodontalnya.

Cara melakukan tes mobilitas :

Kita lakukan penekanan pada gigi yang akan diperiksa dengan jari, pinset atau tangkai dua instrumen ke arah lateral. Bila gigi tersebut goyang, kita tentukan derajat kegoyangannya.

Ada 4 (empat) macam derajat kegoyangan gigi :

- a. Derajat 1 : bila penderita merasakan kegoyangan gigi, tetapi pemeriksa tidak melihat adanya kegoyangan.
- b. Derajat 2 : gigi terasa goyang dan terlihat goyang.
- c. Derajat 3 : kegoyangan gigi ke arah horisontal oleh lidah.
- d. Derajat 4 : kegoyangan ke arah vertikal dan horisontal oleh lidah.

Sebab-sebab terjadinya kegoyangan gigi :

- a. Adanya resorpsi akar, contoh gigi susu
- b. Adanya resorpsi tulang alveolus akibat subgingival kalkulus
- c. Adanya trauma (benturan) misal : jatuh, terpukul benda keras
- d. Adanya penyakit sistemik (diabetes mellitus) yang tidak terkontrol dan tahap lanjut

7. MEMBAU

Pengertian pemeriksaan dengan membau adalah pemeriksaan dengan menggunakan indra penciuman.

Proses terjadinya bau (halitosis) :

Sisa makanan yang tertinggal di dalam kavita / sela-sela gigi bila tidak dibersihkan akan diubah menjadi gas-gas yang berbau seperti NH_3 , H_2S oleh bakteri an aerob.

Halitosis dapat disebabkan 2 faktor :

- a. **Fisiologis** : 1) kurangnya aliran ludah selama tidur
2) makanan dan minuman
3) kebiasaan merokok

4) menstruasi

b. **Patologis** (Kelainan rongga mulut) :

1) oral hygiene buruk

2) plak gigi

3) karies

4) gingivitis

Sebelum melakukan perawatan halitosis harus dilakukan pemeriksaan lengkap :
anamnesis, riwayat medis, riwayat dental termasuk pemeriksaan laboratoris.

Perawatan halitosis (tergantung penyebabnya) :

- a. Bila disebabkan karena makanan, minuman, rokok, ditanggulangi dengan menghindari atau menghentikan konsumsi makanan-makanan tersebut.
- b. Bila karena kondisi-kondisi fisiologis sukar dihindari, penanggulangannya dapat dengan menggunakan bahan kosmetik seperti obat kumur, *mouth spray*, tablet hisap atau makan permen mentol.
- c. Di dalam rongga mulut adanya sisa akar, gigi berlubang, periodontal poket, kalkulus dan lain-lain perawatan yang tujuan utamanya menghilangkan halitosis sehingga harus menghilangkan bakteri dan semua unsur yang retensif.

Cara pemeriksaan dengan membau :

- a. Karies dibersihkan dulu dari sisa-sisa makanan.
- b. Pada karies yang basah : ambil kapas dengan pinset, kemudian ulaskan pada karies, kemudian kapas dibau maka akan tercium bau yang khas.

8. **PALPASI**

Palpasi adalah pemeriksaan dengan cara meraba.

Guna pemeriksaan dengan palpasi :

- a. Mengetahui yang akut dan kronis, misalnya infeksi pada kelenjar submandibula. Pada yang akut, saat palpasi akan terasa sakit, sedang yang kronis tidak terasa sakit tetapi terasa seperti ada biji.
- b. Mengetahui suhu di daerah yang sakit
Misalnya : pada abses, suhu jaringan setempat terasa panas.

- c. Mengetahui keras lunaknya suatu pembengkakan
Misalnya : pada abses yang sudah matang, pada palpasi terasa lunak.
- d. Mengetahui lokasi pembengkakan
- e. Mengetahui adanya fraktur, misalnya : fraktur tulang alveolar

Cara pemeriksaan dengan palpasi :

- a. Pada abses : jari telunjuk kanan diletakkan perlahan-lahan pada daerah pembengkakan dengan sedikit tekanan.
- b. Pada pemeriksaan kelenjar limfe, kepala pasien ditundukkan, ibu jari bertumpu pada pipi. Kemudian kelenjar limfe diraba dari bawah korpus mandibula dengan jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan gerakan memutar secara perlahan-lahan tanpa tekanan. Bila infeksi terbatas pada pulpa dan tidak berlanjut pada periodontium, palpasi tidak merupakan saran diagnostik.

9. TES VITALITAS (TES APE = TES ALAT UJI PULPA ELEKTRONIK)

Untuk melakukan tes vitalitas dari gigi digunakan alat yang disebut vitalitester. Melakukan tes pada pulpa gigi dengan menggunakan listrik lebih cermat dari pada beberapa tes yang digunakan untuk menentukan vitalitas pulpa. Tujuannya adalah untuk merangsang respon pulpa dengan menggunakan arus listrik yang makin meningkat pada gigi. Suatu respon positif merupakan suatu indikasi vitalitas dan membantu dalam menentukan normal atau tidak normalnya pulpa tersebut.

Cara menggunakan Vitalitester :

Gigi yang akan diperiksa dibersihkan dan dikeringkan, jangan lupa memberi penjelasan kepada pasien untuk mengurangi kecemasan dan dapat menghapuskan suatu respon yang menyimpang.

Mula-mula yang diperiksa gigi yang sehat dan senama, kemudian baru pada gigi yang sakit. Ujung vitalitester diolesi dengan pasta gigi. Waktu mengetes mengambil daerah 1/3 dari insisal (oklusal atau insislabial) dan pada daerah email yang baik, tidak boleh melakukan tes langsung pada tumpatan amalgam atau dentin yang terbuka, sebab akan memberikan reaksi yang tidak benar. Pada servikal juga lebih sensitif.

Putar reostat perlahan-lahan untuk memasukkan arus minimal ke dalam gigi, dan menaikkan arus perlahan-lahan. Angka di mana gigi yang sehat bereaksi disebut *irritation point*. Kemudian ujung vitalitester diletakkan pada gigi yang sakit.

Misalnya :

- a. Pada hiperemi pulpa, gigi akan bereaksi sebelum *irritation point*
- b. Pada pulpitis kronis, gigi bereaksi setelah melewati *irritation point*
- c. Pada gigi nonvital gigi tidak memberikan reaksi

hilang dan terbatas pada gigi tertentu.

Cara melakukan Tes Anestetik :

Menggunakan injeksi infiltrasi, lakukan injeksi pada gigi yang paling belakang pada daerah yang dicurigai sebagai penyebab rasa sakit. Bila rasa sakitnya tetap ada setelah gigi dianestesi penuh, lakukan anestesi gigi di sebelah mesialnya, dan lanjutkan melakukan demikian sampai sakitnya hilang. Bila sumber rasa sakit tidak dapat ditentukan, baik pada gigi rahang atas atau rahang bawah, harus diberikan suatu injeksi blok mandibular. Tes ini jelas merupakan suatu usaha yang terakhir dan mempunyai keuntungan dibandingkan tes kavitas, karena selama tes kavitas dapat terjadi kerusakan iatrogenik.

10. TES KAVITAS

Tes kavitas dilakukan dengan mengebor melalui pertemuan email dentin gigi tanpa anestesi. Pengeboran dilakukan dengan kecepatan rendah dan tanpa air pendingin. Sensitivitas atau nyeri yang dirasakan oleh pasien merupakan suatu petunjuk vitalitas pulpa. Bila tidak dirasakan sakit, preparasi kavitas boleh dilanjutkan sampai kamar pulpa dicapai. Bila seluruh pulpa nekrotik, dapat dilanjutkan perawatan endodontik tanpa rasa sakit dan pada banyak kasus tanpa anestesi.

D. KARTU STATUS

1. Pengertian Kartu Status :

Suatu kartu yang diperlukan untuk pencatatan keadaan/ kehadiran penderita.

2. Guna Kartu Status :

- a. Untuk suatu dokumen/ catatan yang perlu disimpan, dari dokumen tersebut kita dapat mencatat suatu data untuk membuat laporan.
 - b. Untuk kepentingan operator, bila penderita itu datang lagi, dari kartu status yang ada kita bisa melihat kembali keadaan semula dan keadaan sekarang. Kemudian kita bandingkan apakah perawatannya berhasil atau tidak.
 - c. Untuk mengetahui bermacam-macam problem, kita dapat mengadakan riset untuk mengetahui penyakit apa yang mempunyai frekuensi tinggi.
- dalam pengisian kartu status perlu dilakukan pencatatan identitas penderita.

3. Guna Pencatatan Identitas Penderita adalah :

- a. Nama : Nama pasien ditanyakan untuk mengetahui identifikasi penderita dan nama dapat membedakan satu penderita dengan penderita yang lain.
- b. Umur : Dengan mengetahui umur penderita kita dapat menentukan rencana perawatan, dosis obat maupun prognosa dari pasien. Misalnya tumor ganas lebih sering terjadi pada usia pertengahan ; pertumbuhan gigi ; indikasi pencabutan gigi susu.
- c. Alamat/Asal : Alamat pasien, gunanya agar dapat dihubungi kembali bila terjadi kesalahan dalam pemberian obat untuk diganti dengan obat yang lain. Ada pengaruh lingkungan / daerah dengan penyakit, contoh : di Afrika ditemukan kelainan email (Hipoplasi / Hipokalsifikasi) dimana kandungan fluor pada ikan di Afrika tinggi sekali.
- d. Jenis Kelamin: Penyakit-penyakit tertentu lebih sering terjadi pada jenis kelamin tertentu, misalnya: Karsinoma pada bibir lebih sering terjadi pada perokok penghisap pipa, jadi lebih sering pada pria misalnya leukoplakia
- e. Pekerjaan : Pada pekerjaan - pekerjaan tertentu dapat menimbulkan kelainan atau manifestasi di dalam mulut, misalnya : tukang kayu mempunyai lekukan-lekukan pada gigi oleh karena pekerjaannya yang sering menggigit paku. Pigmentasi logam berat pada mukosa mulut sering terjadi pada pekerja-pekerja di pabrik (Industri Logam).

BAB II
MATERI II
KELAINAN ANOMALI GIGI

A. PENGERTIAN KELAINAN/ ANOMALI GIGI :

Anomali gigi adalah suatu penyimpangan dari bentuk normal akibat gangguan pada stadium pertumbuhan dan perkembangan gigi.

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB :

1. Faktor herediter
2. Gangguan pada waktu pertumbuhan dan perkembangan gigi
3. Gangguan metabolisme

C. ANOMALI BERDASARKAN JUMLAH

1. KEKURANGAN GIGI (ANODONTIA) :

keadaan dimana benih gigi tidak ada. Ada 2 macam :

- a. *Anodontia Partialis (Agenesis Soliter)* : tidak terbentuk satu atau beberapa gigi
- b. *Anodontia Totalis (Agenesis Absolut)* : tidak adanya seluruh benih gigi

Penyebab : heriditer dan gangguan pada tahap inisiasi dan proliferasi.



Gambar 5 : Anodontia Gigi Incisifus Lateralis

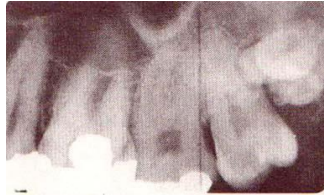
Urutan gigi geligi yang sering terjadi anodontia :

- a. M3 tetap, rahang atas lebih sering daripada bawah
- b. I2 atas tetap
- c. P2 bawah
- d. I1 bawah, bisa gigi susu atau gigi tetap

2. KELEBIHAN GIGI (SUPERNUMERARY TEETH) :

Jumlah gigi yang berlebihan. Macam-macamnya :

- a. Mesiodens : gigi yang terdapat di antara gigi-gigi insisivus sentralis atas



b. Distomolar : Gigi yang terdapat di distal molar 3 atas atau molar 3 bawah.

c. Paramolar : kelebihan gigi di mesio bukal M2 & M3 atas dan bawah

Gambar 6: Mesiodens

Gambar 7: Distomolar

Gambar 8: Paramolar

D. ANOMALI GIGI BERDASARKAN BENTUK

1. ANOMALI BERDASARKAN BENTUK MAHKOTA

a. ***Germinated teeth/ Germinasi/ Gigi kembar***

adalah gigi kembar yang terjadi bila 2 gigi yang sama menjadi satu biasanya mempunyai 1 akar, 1 pulpa dan 2 mahkota.

b. ***Fussion teeth* atau *Kembar Dempet***

adanya 2 gigi menjadi satu dapat terjadi hanya pada mahkota atau pada akar saja atau terjadi pada kedua-duanya.

c. ***Hutchinson teeth***

adanya lekukan pada bagian incisal gigi incisivus.

d. ***Mulberry teeth***

terdapat banyak tonjolan pada mahkota gigi molar. *Hutchinson* dan *mulberry teeth* terjadi karena pada waktu hamil ibu menderita penyakit sifilis.

e. ***Tuberculum carabelli***

adalah tonjolan yang berlebihan pada mesiopalatinal gigi M1 atas.

f. **12 atas tetap**

Gigi anterior yang paling umum mengalami anomali dalam bentuk ialah 12 atas, berbentuk pasak. Biasanya gigi tersebut berbentuk konus, bagian servikal lebar dan mengecil ke arah incisal

g. **P2 bawah**

Morfologi oklusal gigi ini bervariasi dalam :

- Jumlah cusp lingual : dari satu sampai tiga cups, sehingga bentuk *groove* dan *fossa* berubah

- Jumlah akar dua (jarang sekali) 1 mesial dan 1 distal

h. Cups tambahan atau *Tubercle*

Setiap gigi bisa memperlihatkan penonjolan enamel yang sering disebabkan oleh perkembangan hyperplasia setempat/pertumbuhan se-sel baru :

i. Molar ketiga

M3 atas mempunyai bentuk mahkota yang paling bervariasi dari seluruh gigi geligi tetap, kemudian M3 bawah.

2. ANOMALI BERDASARKAN BENTUK AKAR

a. Dilaserasi

adalah akar dan mahkota gigi yang sangat bengkok / distorsi, sering membentuk sudut 45 derajat sampai lebih dari 90 derajat.

b. *Concrescence*

Keadaan ini adalah *fusion* atau tumbuh jadi satu pada akar gigi melalui sementum saja, biasanya menjadi satu setelah gigi erupsi dalam rongga mulut. Sering terjadi pada regio Molar atas.

c. Hipersementosis

Pembentukan jaringan sementum yang berlebihan sekitar akar gigi setelah gigi erupsi, dapat disebabkan oleh trauma, gangguan metabolisme, atau infeksi periapikal.

d. Ankylosis

Gigi menjadi satu dengan tulang

e. *Flexion*

Akar gigi yang bengkok kurang dari 90 derajat atau mutar

f. *Dwarfed Root*

Gigi-gigi atas sering memperlihatkan mahkota gigi dengan ukuran normal tetapi dengan akar yang pendek.

g. Akar Tambahan

Biasanya terjadi pada gigi yang akarnya terbentuk setelah individu lahir, mungkin disebabkan oleh trauma, gangguan metabolisme atau tekanan. C dan P bawah, M3, *dilaceration*, *flexion* sering memperlihatkan gigi dengan akar supernumerary atau

tambahan.

E. ANOMALI BERDASARKAN UKURAN

3. Mikrodonsia : gigi dengan ukuran lebih kecil dari ukuran normal
4. Makrodonsia : gigi dengan ukuran lebih besar dari ukuran normal

Mikrodonsia dan Makrodonsia terjadi karena gangguan tahap morfodiferensiasi

F. ANOMALI POSISI GIGI

adalah penyimpangan posisi gigi dari posisi normal diakibatkan oleh gangguan dalam stadium pertumbuhan dan perkembangan.

5. Mal Oklusi : oklusi yang menyimpang dari normal
6. Rotasi / Torsiversi : gigi berputar pada porosnya
7. *Misplaced teeth* (Transposisi) : benih gigi keluar dari tempatnya sehingga gigi erupsi tidak pada tempatnya. sering terjadi pada gigi C atas dan C bawah.
8. Elongasi : lebih memanjang dari normal
9. Mesioversi : lebih ke mesial daripada normal
10. Distoversi : lebih ke distal daripada normal
11. Bukoversi : lebih ke bukal daripada normal
12. Palatoversi : lebih ke palatal daripada normal
13. Linguoversi : lebih ke lingual daripada normal
14. *Crowded* : keadaan gigi yang berjejal
15. Diastema : keadaan gigi yang jarang
16. Impaksi/*Impacted*/Gigi tidak erupsi : keadaan dimana suatu gigi terganggu erupsinya karena kekurangan daya erupsi, rintangan mekanis, sering karena ukuran rahang yang kecil. Impaksi bisa sebagian ataupun seluruhnya.

Penyebab :

- a. Kekurangan tempat
- b. Posisi gigi yang tidak teratur dan tekanan dari gigi sampingnya, dalam hal ini M2
- c. Tebalnya tulang yang menutupi dan mengelilingi gigi tersebut
- d. Mukosa yang menutupi gigi terlalu tebal
- e. Gigi susu yang terlalu cepat tanggal

Komplikasi-Komplikasi yang dapat terjadi akibat impaksi M3:

- a. Perikoronitis dan atau operkulitis
- b. Abses Alveolar akut atau kronis

- c. Trismus
- d. Fraktur tulang
- e. Kista

G. ANOMALI STRUKTUR GIGI

A. *Amelogenesis Imperfecta*

Anomali struktur gigi karena gangguan fungsi enamel organ sehingga pembentukan enamel tidak sempurna

Tanda-tandanya :

- f. Warna dari putih ke kuning dan coklat
- g. Email berlubang-lubang dan kasar

Macamnya :

- a. Hipoplasia email : adalah gangguan pada ameloblas saat pembentukan matriks email.
- b. Hipokalsifikasi : gangguan saat pematangan, warnanya kurang bagus

Penyebab :

- a. Obat misalnya tetrasiklin, flour
- b. Penyakit sistemik misalnya penyakit *siphilis* (gigi *Hutchinson*, gigi *Mulberry*)
- c. Infeksi lokal dari gigi susu

B. *Dentinogenesis Imperfecta*

Gangguan pembentukan dentin sehingga pembentukan dentin tidak sempurna.

H. ANOMALI ERUPSI

Erupsi prematur : gigi bererupsi sebelum waktunya, terlihat pada bayi yang baru dilahirkan.

Persistensi : gigi susu yang terlambat tanggal / tidak tanggal pada waktunya sedangkan gigi tetap penggantinya sudah erupsi.

BAB III
MATERI III
KELAINAN JARINGAN KERAS GIGI DAN JARINGAN PULPA

A. KELAINAN JARINGAN KERAS GIGI DAN JARINGAN PULPA

1. PENGERTIAN KELAINAN JARINGAN KERAS GIGI

Kelainan jaringan keras gigi adalah terjadinya kerusakan-kerusakan pada email dan dentin yang disebabkan oleh berbagai rangsang

2. PENGERTIAN KELAINAN JARINGAN PULPA

Kelainan yang mengenai jaringan pulpa yang meliputi Inflamasi, degenerasi sampai terjadinya kematian pulpa oleh berbagai sebab

3. PENYEBAB KELAINAN JARINGAN KERAS GIGI DAN JARINGAN PULPA

a FISIS

1) MEKANIS

a) Trauma

(1) Kecelakaan

(2) Prosedur gigi Iatrogenik

b) Pemakaian Patologik

c) Retak melalui badan gigi

d) Perubahan Barometrik

2) THERMIS

a) Panas berasal dari preparasi kavita

b) Panas eksotermik pada proses pengerasan semen

c) Konduksi panas dan dingin melalui tumpatan tanpa semen base

d) Panas Friksional (pergesekan) pada proses pemolasan

e)

B. KELAINAN JARINGAN KERAS GIGI

1. KEHILANGAN JARINGAN KERAS GIGI / KEAUSAN

a. EROSI

Hilangnya jaringan keras gigi sebagai akibat dari proses kimia yang tidak melibatkan bakteri

Penyebab ;

- 1) Erosi karena muntah
- 2) Erosi karena diet
- 3) Erosi karena pekerjaan

b. ATRISI

Hilangnya jaringan keras gigi pada bagian incisal dan oklusal dari permukaan gigi yang berlawanan, dapat disebabkan karena fungsi pengunyahan ataupun karena kebiasaan buruk (*bruxism*)

c. ABRASI

Hilangnya jaringan keras gigi yang disebabkan karena proses mekanis seperti pada penggunaan sikat gigi, pemakaian tusuk gigi yang salah, pada kebiasaan pangur/gusar.

d. ABFRAKSI

Hilangnya jaringan keras gigi yang terjadi pada daerah servikal labial/ bukal gigi orang dewasa, penyebabnya biasanya karena *fatigue* (kelelahan gigi), fraktur dan deformasi dari struktur gigi sebagai akibat dari tekanan biomekanis

2. KEHILANGAN JARINGAN KERAS GIGI KARENA KARIES

a. Pengertian karies gigi

Karies adalah penyakit pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh kerja mikroorganisme pada karbohidrat yang dapat diragikan. Karies ditandai dengan adanya demineralisasi mineral-mineral email dan dentin, diikuti kerusakan bahan-bahan organiknya. Ketika makin mendekati pulpa, karies menimbulkan perubahan-perubahan dalam bentuk dentin reaksioner dan pulpitis (mungkin disertai nyeri) dan bisa berakibat terjadinya invasi bakteri dan kematian pulpa. Jaringan pulpa mati yang terinfeksi ini selanjutnya akan menyebabkan perubahan di jaringan periapikal.



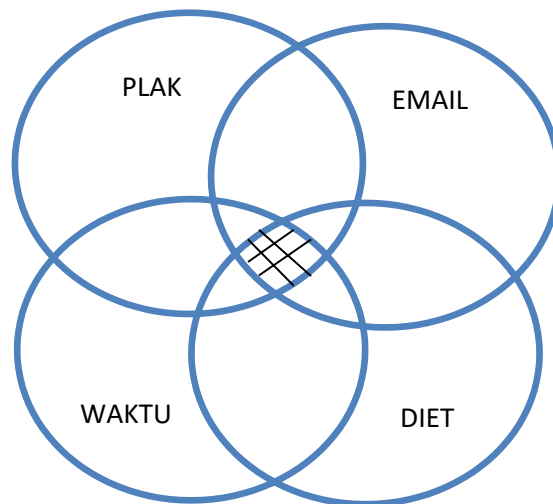
Gambar9:KariesGigi

b. Etiologi

4 faktor penting yang dapat menimbulkan karies, adalah :

- 1) Plak gigi
- 2) Diet : karbohidrat yang cocok (terutama gula)
- 3) Email : Permukaan gigi yang rentan
- 4) Waktu.

Karies akan terjadi apabila keempat faktor tersebut bekerja secara simultan (Kidd, 2000)



c. Faktor-faktor yang dapat membantu terjadinya karies gigi

Beberapa faktor yang dapat membantu terjadinya karies gigi :

- 1) Gigi :
 - a) Campuran bahan-bahan pembentuk gigi
 - b) Bentuk morfologi gigi
 - c) Posisi gigi-gigi dalam deretan.
- 2) Saliva :
 - a) Campuran bahan-bahan yang terkandung di dalamnya
 - b) derajat keasaman
 - c) Jumlah/ volume
 - d) faktor anti bakteri
- 3) Makanan :

- a) Macam/ jumlah
- b) Kandungan karbohidrat
- c) Kandungan vitamin

d. Letak karies

Daerah yang sering terkena karies yaitu :

- 1) Permukaan email berfisur
- 2) Permukaan email halus
- 3) Permukaan akar
- 4) Sekitar tumpatan.

e. Kedalaman Karies

1) Karies Superfisialis

Diagnosa ; IRITASI PULPA

a) Pengertian

Suatu keadaan di mana lapisan email telah mengalami kerusakan sampai batas Dentino Enamel Junction yang merupakan tempat terakhir dari ujung-ujung syaraf yang sudah dapat dirangsang

b) Penyebab-penyebab

- (1) Plak
- (2) Faktor mekanis, misal; cara menyikat gigi yang salah

c) Gejala-gejala

- (1) Linu bila terkena rangsangan dingin, manis, asam dan bila terkena sikat gigi
- (2) Rasa linu hilang bila rangsangan dihilangkan

d) Rencana Perawatan

Tumpatan, sesuai indikasi

2) Karies Media

Diagnosa : HIPEREMI PULPA

a) Pengertian

Suatu keadaan di mana kerusakan sudah sampai ke lapisan dentin, merupakan keadaan lanjut dari iritasi pulpa

b) Penyebab

- (1) Plak
- (2) Trauma

c) Gejala-gejala

- (1) Terasa linu bila kena rangsang manis, asam, dingin, panas (kadang-kadang)
- (2) Bila rangsang dihilangkan, rasa linu tetap bertahan ½ - 1 menit
- (3) Kadang-kadang linu bila kemasukan makanan

d) Proses terjadinya (secara Histopatologis)

Akibat masuknya toksin ke dalam kamar pulpa melalui saluran dentin, maka pulpa memberikan reaksi berupa pelebaran pembuluh darah dalam pulpa, sehingga siklus darah pada pulpa bertambah. Pada kasus hiperemi pulpa sering terjadi dentin tertier (sklerotik)

e) Rencana Perawatan

Tumpatan sesuai indikasi (pada kartu status ditulis pro-konservasi)

3) Karies profunda

Diagnosa : PULPITIS

a) Pengertian

adanya peradangan pada jaringan pulpa

b) Pembagian Pulpitis

(1) Menurut lamanya perjalanan penyakit pulpa

- (a) Pulpitis Akut
- (b) Pulpitis kronis

(2) Menurut luas kerusakan pulpa

- (a) Pulpitis Partialis
- (b) Pulpitis Totalis

e. Pencegahan karies

Mencegah penyakit ini memerlukan bakteri plak, substrat karbohidrat, dan permukaan gigi yang rentan, maka terdapat tiga cara dalam pencegahan karies, yaitu :

- 1) Hilangkan substrat karbohidrat
- 2) Meningkatkan ketahanan pejamu
- 3) Hilangkan bakteri plak. (Kidd, 2000)

f. Karies rampan

Kerusakan yang sangat cepat pada beberapa gigi, sering terjadi pada permukaan gigi yang biasanya relatif bebas karies, terutama pada :

- a) Gigi geligi sulung

- b) Gigi permanen pada anak usia belasan tahun
- c) *Xerostomia*/ kekurangan ludah.(Kidd, 2000)

C. KELAINAN JARINGAN PULPA

1. PENGERTIAN KELAINAN JARINGAN PULPA

Peradangan Jaringan Pulpa

Peradangan jaringan Pulpa disebut Pulpitis adalah suatu peradangan (inflamasi) pulpa yang bisa sembuh kembali atau terus berlanjut. Penyembuhan bisa terjadi pada peradangan ringan, sedangkan pada peradangan parah pada umumnya akan meningkat menjadi nekrosis dan akhirnya dapat menimbulkan abses.

2. KLASIFIKASI PERADANGAN JARINGAN PULPA

a. PERADANGAN JARINGAN PULPA REVERSIBEL

Suatu kondisi inflamasi pulpa ringan sampai sedang yang disebabkan oleh rangsangan, pulpa bisa kembali pada keadaan tidak terinflamasi setelah rangsangan dihilangkan.

Penyebab :

- 1) Trauma
- 2) Syok termal
 - a) Preparasi dengan bur tumpul
 - b) Bur terlalu lama kontak dengan gigi
 - c) Pemolesan tumpatan terlalu lama.
- 3) Dehidrasi kavitas oleh alkohol yang berlebihan
- 4) Rangsangan pada leher gigi dengan dentin terbuka
- 5) Tumpatan amalgam yang kontak atau beroklusi dengan restorasi emas.

Gejala :

1) PULPITIS REVERSIBEL SIMTOMATIK (AKUT)

- a) Rasa sakit tajam, sebentar terutama disebabkan oleh makanan/ minuman dingin atau udara dingin
- b) Tidak ada rasa sakit spontan
- c) Rasa sakit hilang jika rangsangan dihilangkan.

2) PULPITIS REVERSIBEL ASIMTOMATIK

Dapat disebabkan karena karies yang baru mulai dan menjadi normal kembali

setelah karies dihilangkan serta gigi direstorasi dengan baik

- a) Rasa sakit tajam beberapa detik.

Rasa sakit hilang jika rangsangan dihilangkan.

- b) Terasa sakit dengan rangsangan dingin, manis, asam.

b. PERADANGAN JARINGAN PULPA IREVERSIBEL

Suatu keadaan inflamasi pulpa yang persisten, dapat simtomatik atau asimtomatik dan disebabkan oleh suatu rangsangan.

Penyebab :

- 1) Selain faktor fisis & kimiawi, penyebab paling umum adalah bakteri melalui karies gigi.
- 2) Akibat lanjut dari pulpitis reversibel.

Pada Pulpitis Ireversibel

- 1) Akut ;
 - a) Responsif terhadap dingin
 - b) Responsif terhadap panas
- 2) Kronis ;
 - a) Pulpa terbuka
 - b) Pulpitis hiperplastik
 - c) Resorpsi internal

1) PULPITIS IREVERSIBEL AKUT

Gejala :

- a) Sakit dengan rangsang panas/ dingin, manis, asam dan rasa sakit ini bertahan beberapa menit sampai beberapa jam dan tetap sakit meskipun rangsang dihilangkan.
- b) Sakit spontan, sakit bila kavitas tertekan makanan
- c) Rasa sakit menyebar ke gigi di dekatnya, ke pelipis atau telinga bila gigi bawah belakang yang terkena
- d) Pasien tidak dapat tidur karena sakitnya tidak tertahankan meskipun sudah

diberi analgetik

2) PULPITIS IREVERSIBEL KRONIS

a) ASIMTOMATIK PULPITIS IREVERSIBEL DENGAN PULPA TERBUKA

Gejala :

- (1) Ada sedikit rasa sakit atau mungkin tidak sakit, kecuali bila kavitas tertekan makanan
- (2) Lebih sakit dengan dingin
- (3) Sakit spontan terlokalisir.

3) PULPITIS HIPERPLASTIKA KRONIS = PULPA POLIP

Penyebab :

Terbukanya pulpa karena karies yang lambat dan progresif, disertai rangsangan rendah dan kronis.

Gejala :

- (1) Tidak sakit kecuali kavitas atau polip tertekan makanan
- (2) Mudah berdarah.
- (3)

4) NEKROSIS PULPA

Pengertian : Nekrosis adalah kematian pulpa, dapat sebagian atau seluruhnya. Nekrosis meskipun suatu akibat inflamasi, dapat juga terjadi setelah injuri traumatik yang pulpanya rusak sebelum terjadi reaksi inflamasi

Ada 2 jenis nekrosis :

a. KOAGULASI / PENGUMPALAN

Jaringan pulpa yang telah mengalami kematian berubah menjadi masa seperti keju.

b. LIKUIFAKSI / PENCAIRAN

Jaringannya berubah menjadi masa yang lunak, suatu cairan. Hasil lanjutan seperti indol, skatol menambah bau tidak enak yang sering keluar dari saluran akar.

Penyebab :

- a. Bakteri
- b. Trauma
- c. Iritasi
- d. kimiawi

Gejala :

Tidak ada
rasa sakit.

Pemeriksaan klinis :

- a. Gigi berubah warna keabu-abuan atau kecoklat-coklatan
- b. Tidak ditemukan karies ataupun tumpatan bila penyebabnya trauma
- c. Tidak bereaksi terhadap tes dingin, tes pulpa listrik ataupun tes kavitas.

BAB IV
MATERI IV
PENYAKIT / KELAINAN PADA JARINGAN PENYANGGA GIGI
DAN JARINGAN LUNAK MULUT

A. PENGERTIAN JARINGAN PENYANGGA GIGI

Merupakan suatu jaringan pendukung gigi yang terletak di antara sementum dan tulang alveolar

B. JARINGAN PENYANGGA GIGI TERDIRI DARI :

1. Gingiva
2. Periodontal Membran
3. Sementum
4. Prosesus Alveolaris / Tulang Alveolar

1. GINGIVA

Adalah bagian dari oral mukosa yang melekat pada gigi dan tulang alveolar

Gingiva terdiri dari :

- a. Marginal Gingiva adalah bagian dari *free gingiva* yang terletak di bagian labial, bukal dan lingual
- b. Interdental Papil adalah bagian dari marginal gingival yang memenuhi *interproximal space* (ruang antara dua gigi)
Free gingiva adalah bagian dari marginal gingival yang mengelilingi gigi tapi tidak lekat pada permukaan gigi
Free gingiva ini yang membentuk sulkus gingiva
- c. *Free gingival groove* adalah lekukan yang terdapat antara *free gingival* dan *attached gingival*
- d. *Attached gingival* adalah bagian gingiva melekat pada gusi atau prosesus alveolaris yang memberikan *texture* (bentuk) *stipled*
- e. *Muco gingival junction* adalah garis pemisah antara *attached gingival* dan *alveolar mucosa*

TANDA-TANDA GINGIVA SEHAT :

- a. Berwarna merah jambu atau pada beberapa ras tergantung warna kulit
- b. Interdental papil mengisi ruang interproksimal sampai titik kontak dan sudutnya runcing

- c. Bagian margin (tepi gingiva) tipis dan tidak bengkak
- d. Permukaan gingiva tidak rata tapi ada *stippled* (seperti kulit jeruk)
- e. Gingiva lekat sekali pada gigi dan prosesus alveolaris
- f. Sulkus gingiva tidak dalam ≤ 2 mm, jika > 2 mm disebut poket
- g. Tidak ada eksudat (cairan) dan tidak mudah berdarah

2. PERIODONTAL MEMBRAN

Adalah jaringan ikat yang menghubungkan gigi dengan tulang alveoli atau jaringan ikat yang terletak antara prosesus alveolaris dan sementum yang mengelilingi gigi .

Periodontal Membran terdiri dari :

- a. Serabut – serabut jaringan ikat yang dinamakan *Sharpey's fiber*
- b. Sel- sel jaringan ikat
- c. Sisa- sisa epitel pembentuk gigi
- d. Pembuluh darah, pembuluh limfe dan urat syaraf

Fungsi Periodontal Membran :

- a. meneruskan daya kunyah ke tulang alveolar
- b. melekatkan gigi pada tulang
- c. mempertahankan jaringan gingiva pada tempatnya
- d. menghilangkan tekanan dari luar
- e. meresorpsi dan memperbaiki sementum dan tulang alveolar
- f. mengganti periodontal ligamen dengan yang baru
- g. sebagai fungsi sensoris, artinya meneruskan rangsang dari syaraf misal dari apek gigi ke otak
- h. memberi makanan pada jaringan penyangga gigi lain melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe

3. SEMENTUM

Meliputi seluruh permukaan akar gigi

Gunanya :

- a. melindungi permukaan akar
- b. memegang ujung- ujung serat periodontal yang melekat pada gigi

4. PROSESUS ALVEOLARIS / TULANG ALVEOLAR

Merupakan bagian tulang rahang tempat gigi- gigi tertanam

C. PENYAKIT JARINGAN PENYANGGA GIGI

1. PEMBESARAN GUSI (*GINGIVAL ENLARGEMENT*)

Pengertian : Salah satu bentuk perubahan patologis dari gingiva yang mengalami *Hyperplasia* (bertambah besarnya jaringan karena terjadi proliferasi atau bertambahnya sel) atau *Hypertropi* (pembesaran jaringan disebabkan ukuran sel yang membesar)

D. PENYAKIT JARINGAN PENYANGGA GIGI

1. PEMBESARAN GUSI (*GINGIVAL ENLARGEMENT*)

Pengertian : Salah satu bentuk perubahan patologis dari gingiva yang mengalami *Hyperplasia* (bertambah besarnya jaringan karena terjadi proliferasi atau bertambahnya sel) atau *Hypertropi* (pembesaran jaringan disebabkan ukuran sel yang membesar)

A. PERADANGAN GINGIVA (*GINGIVITIS*)

Pengertian :

Peradangan pada gingiva yang menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit/ kelainan pada gingiva

Pembagian :

- a. lokal : mengenai satu gigi atau satu regio
- b. general : mengenai seluruh gigi
- c. marginal : mengenai tepi-tepi gigi

Penyebab :

Gingivitis disebabkan oleh plak dan dipercepat adanya faktor iritasi lokal dan sistemik

Macam iritasi lokal yang dapat menyebabkan gingivitis :

- a. *materia alba*
- b. karang gigi
- c. *overhanging filling* (tambalan berlebih)
- d. obat, misal; Arsen, Phenol

Macam-macam faktor sistemik

- a. ketidak seimbangan hormonal (diabetes, pubertas, kehamilan)
- b. kelainan darah
- c. malnutrisi

- d. obat-obatan, misalnya Dilantin sodium

1. GINGIVITIS MARGINALIS

Pengertian :

Gingivitis marginalis adalah peradangan gingiva bagian marginal yang merupakan stadium yang paling awal dari penyakit periodontal

Macam-macam gingivitis :

Berdasarkan lamanya penyakit

- Gingivitis marginalis akut
- Gingivitis marginalis kronis

Faktor-faktor predisposisi gingivitis :

- 1) Hormonal ; a) *Puberty gingivitis*
b) *Pregnancy gingivitis*
- 2) Defisiensi vitamin ; *Scorbutic gingivitis*
- 3) Penyakit ; *ANUG (Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis)*

a. GINGIVITIS MARGINALIS AKUT

Tanda-tanda klinis :

- b. warna merah
- c. mengkilat
- d. bengkak
- e. mudah berdarah
- f. terdapat eksudat
- g. sakit

b. GINGIVITIS MARGINALIS KHRONIS

Tanda-tanda klinis :

- warna merah bisa berubah menjadi kebiruan
- bengkak
- tidak mudah berdarah
- biasanya tidak sakit
- terdapat eksudat

c. PUBERTY GINGIVITIS

Tanda-tanda klinis :

- terjadi pada masa pubertas
- gingiva mengalami hiperplasi
- gingiva mengalami pembengkakan yang merata

- berwarna merah kebiruan
- oral hygiene buruk

d. SCORBUTIC GINGIVITIS

Tanda-tanda klinis :

- terjadi karena defisiensi vitamin C
- oral hygiene buruk
- peradangan terjadi menyeluruh dari interdental papil sampai dengan *attached gingiva*
- warna merah terang atau merah menyala
- ada hiperplasi dan ulserasi

2. PERADANGAN JARINGAN PENYANGGA (PERIODONTITIS)

Pengertian :

peradangan dari jaringan penyangga gigi yang meliputi gingiva, serabut-serabut periodontal, sementum dan tulang alveolar sebagai akibat lanjut dari gingivitis yang tidak dirawat

Penyebab :

Iritasi lokal dan traumatik oklusi

Pembagian Periodontitis

a. Menurut waktu terjadinya

- 1) periodontitis akut
- 2) periodontitis kronis

b. Menurut perluasan periodontitis (melalui tempat terjadinya)

- 1) melalui karies
- 2) melalui marginal / leher gigi

c. Menurut tempat peradangan

- 1) Periodontitis Marginalis

2) Periodontitis Apikalis

a. PERIODONTITIS MARGINALIS

Pengertian

Peradangan dari jaringan penyangga gigi yang mengenai gingiva sampai dengan periodontal ligamen

Gejala-gejala :

- 1) bau tidak enak
- 2) rasa sakit di dalam tulang
- 3) Rasa gatal pada gingiva
- 4) Keinginan penderita untuk mengisap darah dari *interproximal space*

Tanda-tanda klinis

- 1) Terjadi peradangan pada gusi seperti gingivitis
- 2) Adanya poket yang fisiologis (*real pocket*)
- 3) Adanya eksudat dari poket
- 4) Jika akut → sakit
- 5) jika kronis → tidak sakit



Gambar 10

Rencana Perawatan

- 1) Pencegahan
 - a) Peningkatan oral hygiene (kontrol plak)
 - b) Perbaikan gizi
- 2) Pengobatan
 - a) Pembersihan karang gigi

- b) Pemberian obat : (1) antimikroba & analgetik
(2) antiseptik

b. PERIODONTITIS APIKALIS

Pengertian :

Peradangan jaringan periodontal di sekitar apeks gigi sebagai kelanjutan dari peradangan pulpa yang menyeluruh atau karena trauma

Sebab terjadinya :

- 1) Pulpitis akut totalis yang tidak diobati
- 2) Nekrose pulpa

Gejala-gejala :

- 1) sakit berdenyut-denyut
- 2) gigi terasa memanjang
- 3) sakit saat oklusi
- 4) sakit apabila terkena makanan panas

Tanda-tanda klinis :

- 1) perkusi dan tekanan sakit
- 2) palpasi pada mukosa daerah apeks kadang-kadang sakit
- 3) bisa terjadi pada gigi non vital atau vital

Rencana perawatan :

- 1) Pemberian obat antimikroba & analgetik
- 2) Pencabutan atau perawatan saluran akar

B. PENYAKIT / KELAINAN JARINGAN LUNAK MULUT

a. PENYAKIT / KELAINAN BIBIR

Macam- macam Kelainan pada Bibir

a. CHEILITIS

Merupakan infeksi yang mengenai sudut bibir

b. CHEILITIS EKSPOLIATIF

Adalah kelainan atopik pada bibir terjadi karena kontak dengan agen tertentu, infeksi mikroorganisme, efek samping pengobatan

c. CELAH BIBIR

Merupakan cacat bawaan berupa celah pada bibir (*labiochisis*) dapat terjadi bilateral

atau unilateral, terjadi kegagalan penyatuan antara prosesus lasalis dan prosesus maksilaris pada embrio trimester pertama



Gambar 11

b. PENYAKIT/ KELAINAN LIDAH DAN DASAR MULUT

a. GLOSITIS

Peradangan pada lidah , yang ditandai dengan deskuamasi papila filiformis sehingga menghasilkan daerah kemerahan yang mengkilat.

b. GEOGRAFIC TONGUE (LIDAH GEOGRAFIK)

Gambaran pola seperti peta pada permukaan dorsum lidah yang tidak diketahui penyebabnya, sering terjadi pada wanita

c. MEDIAN RHOMBOID GLOSITIS

Berupa persistensi tonjolan di median posterior lidah akibat kegagalan fungsi tuberkulum impar pada masa embrio

d. HIPERTROPI PAPILA LIDAH

Disebabkan karena peradangan akibat iritasi kronis atau infeksi

e. LIDAH BERSELAPUT / *HAIRY TONGUE*

Permukaan dorsum lidah ditutupi oleh selaput atau pseudo membran karena terjadinya infeksi.(*Scarlet fever*).

f. ATROFI PAPILA LIDAH

Menghilangnya papila yang terdapat pada lidah , keadaan ini disebabkan oleh kebiasaan membersihkan lidah atau sebab mekanis lainnya , seperti trauma tepi tambalan, gigi tiruan, alat ortho, gigi tajam atau karena hipersensitif obat-obat gigi seperti Chkm, Tkf, defisiensi besi , B.Komplek, hal ini menyebabkan atrisi pada

papila filiformis.

g. FISSURE TONGUE (LIDAH BERFISUR)

lidah tampak seperti retak- retak disebut *Plicated tongue*

h. GLOSODINIA

- 1) Glosodinia : pasien merasa panas / terbakar pada lidah (*Burning mouth sindrome*)
- 2) Glosopirosis: pasien merasa terbakar pada lidah, sering terjadi pada pasien diatas 50 tahun

i. ANKILOGLOSIA

Lidah melekat pada dasar mulut secara keseluruhan atau ujungnya saja. Penyebabnya adalah fusi lidah dengan dasar mulut pada pertumbuhan janin.

j. MAKROGLOSIA

Lidah berukuran besar dibandingkan dengan normal. Mulut terlihat penuh oleh lidah.

k. MIKROGLOSIA

Ukuran lidah lebih kecil dari normal.

l. KELENJAR LUDAH

- 1) **Sialolitiasis** : terbentuknya batu dalam kelenjar ludah atau saluran , sehingga menghambat aliran ludah

c. KELAINAN MUKOSA MULUT, BIBIR DAN LIDAH

a. STOMATITIS

STOMATITIS APHTOSA REKUREN

Stomatitis yang terjadi berulang tanpa disertai tanda atau gejala penyakit lain.

Penyebab :

herediter, defisiensi Fe, B12, asam folat, gangguan immonologi, stres, trauma, gangguan hormonal, infeksi bakteri dan virus.

Berdasarkan bentuk dan besarnya ulser ada 3 yaitu ;

- a) Ulser minor, ulser mayor dan ulser herpetifom. Ulser minor dengan ukuran < 1 cm sembuh 7 sampai 10 hari tanpa pengobatan,
- b) Ulser mayor dengan ,ukuran > 1 sampai 5 cm jangka waktu lama beberapa minggu sampai beberapa bulan dan meninggalkan jaringan parut.
- c) Ulser herpetifom dengan diameter 0,1 sampai 0,3 cm dalam jumlah lebih dari satu



d. RADANG

a. PENGERTIAN RADANG

Radang adalah reaksi positif dari tubuh untuk membatasi masuknya berbagai

b. GEJALA-GEJALA RADANG

1) Rubor (merah)

terjadi karena jaringan yang meradang mengandung banyak darah akibat kapiler-kapilernya melebar dan kapiler-kapiler yang tadinya kosong menjadi berisi darah.

2) Kalor (panas)

akibat sirkulasi darah yang meningkat, maka volume darah juga meningkat mengakibatkan kandungan oksigen juga bertambah sehingga menimbulkan panas.

3) Tumor (pembengkakan)

disebabkan sebagian oleh hiperemi dan sebagian besar oleh eksudat yang terjadi pada radang

4) Dolor (rasa nyeri)

disebabkan pengaruh zat pada ujung saraf perasa yang dilepaskan oleh sel yang cedera, zat ini mungkin histamin. Rasa nyeri mungkin juga disebabkan oleh tekanan yang tinggi dalam jaringan akibat terjadinya eksudat.

5) Functio laesa

bagian yang meradang tersebut tidak bisa dipergunakan dengan baik. Gejala-gejala radang ini disebut juga *Cardinal symptom*

c. PEMBAGIAN RADANG

1) Menurut waktunya :

(a) Radang Akut (berjalan cepat) :

keadaan rubor, calor, tumor, dolor dan functio laesa tampak lebih jelas. Rasa sakit spontan dan berdenyut.

(b) Radang Kronis (berjalan lambat) : tidak semua tanda-tanda radang tampak dengan jelas. Apabila daya tahan tubuh cukup baik, sakit hanya kadang-kadang

d. KISTA

Kista adalah suatu rongga patologis yang tumbuh secara abnormal berisi cairan dalam suatu kapsul yang dibatasi membran

Penyebab Kista : - trauma

- Radang
- Gangguan pertumbuhan
- Retensi

BAB V
MATERI V
PENYAKIT-PENYAKIT SISTEMIK YANG
BERMANIFESTASI DI DALAM MULUT

- a. Gangguan Hormonal : Diabetes Mellitus
- b. Kelainan Darah : Leukemia
- c. Defisiensi Vitamin : Def. Vit A, B1, B2, B6, Def. poliacid Vit A, B12, B Komplek, C, D

Penyakit-penyakit karena bakteri/virus : TBC, Syphilis, Mumps, Hepatitis, Aids

a) **Gangguan Hormonal**

Diabetes Mellitus : Suatu keadaan dimana kadar gula di dalam darah meninggi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya jumlah hormon yang menurun, yaitu hormon insulin.

Fungsi insulin : Menambah glukosa menjadi glycogen dan disimpan dalam hati.

Gejala umum DM :

- Polyphagia (banyak makan)
- Polydipsi (banyak minum)
- Polyuria (banyak kencing)
- Pruritis (Gatal-gatal)
- Peradangan mulut (Periodontitis, Paradontosis atau Pyorrhoe Alveolaris)

Intra Oral :

- a. Gusi membengkak berwarna merah, sakit dan biasanya agak lepas dari gigi.
- b. Resorpsi Prosesus Alveolaris
- c. Caries incidence meningkat
- d. Jumlah saliva menurun
- e. Mulut bau aseton
- f. Lidah kering dan sakit seperti terbakar
- g. Gigi-gigi goyang

Therapy Intra Oral :

1. Perawatan gigi 3-4 bulan sekali
2. Calculus dihilangkan
3. Dilakukan X-ray tiap tahun
4. Perawatan gigi sebaiknya bertahap
5. Cara sikat gigi yang baik
6. Pro dan post operative diberikan antibiotik

7. Pemberian vit.B komplek dan vit.C (dosis tinggi) akan mempercepat penyembuhan

b) Kelainan Darah

Leukemia

ialah suatu keadaan dimana jumlah leucosit lebih banyak dari pada normal dan jumlah yang ada masih muda sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya untuk membunuh kuman mudah terkena infeksi.

Gejala dari Leukemia:

- a. adanya demam yang tinggi suhu 40°C
- b. penderita kelihatan lemas
- c. seluruh badan terasa sakit terutama pada sendi-sendi dan tulang
- d. mudah terjadi perdarahan
- e. pembesaran dari hati, ginjal dan limpa

Intra Oral:

1. Adanya penebalan dari gusi secara menyeluruh (bisa sampai menutupi oclusal dari gigi)
2. Gusi mudah berdarah
3. Pendarahan pada mukosa mulut
4. Pulpa gigi menjadi abses pada gigi yang sehat
5. Ulserasi pada bibir.

BAB VI
MATERI VI
PENYAKIT-PENYAKIT YG DISEBABKAN INFEKSI DARI GIGI/
FOCAL INFECTION

Pengertian:

Infeksi dari jaringan yang disebabkan adanya metastase kuman atau toksin yang berasal dari sumber infeksi yang letaknya jauh dari jaringan tersebut. Sarang infeksi disebut juga *focus of infection*, yaitu daerah atau jaringan yang terinfeksi dengan kuman-kuman yang letaknya diantara jaringan sehat.

Keadaan-keadaan yang merupakan focus/ sumber infeksi:

1. gigi yg nekrose
2. gigi yang pada akarnya terdapat granuloma
3. penyakit periodontal.

Dengan adanya *focus of infection* di mulut, maka bias terjadi infeksi di tempat lain yang asalnya dari focus on infection di mulut.

Cara penyebaran *focal infection*:

Secara hematogen/ melalui aliran darah atau secara limfogen/ melalui aliran limfe.

Contoh *focal infection*:

1. Nephritis/ radang ginjal

Dapat berupa:

- a. Glomerulonephritis: bias disebabkan oleh berbagai macam sebab dan patogenesis yang mengakibatkan kesalahan fungsi ginjal
- b. Pyelonephritis: disebabkan oleh infeksi bakteri ke dalam ginjal, paling banyak oleh karena *Escherichia coli*.

Gejala-gejala penyakit ginjal:

- a. demam, menggigil
- b. mual, muntah
- c. warna air kemih keruh kecoklatan
- d. buang air kecil sakit, panas
- e. hipertensi

Rencana perawatan: konsul ke dokter umum/ dokter spesialis

2. Endokarditis

Gejala-gejala penyakit jantung:

- a. nyeri yang sangat dan mendadak di dada tetapi biasanya substernal, bias juga di punggung kiri, lengan atau gerakan bawah
- b. tekanan darah menurun hingga keadaan shock. Pada serangan yang parah terjadi dyspnose dan sianosis

Rencana perawatan: konsul ke dokter umum/ dokter spesialis

3. Dermatitis: radang jaringan kulit

Penyebab:

- a. infeksi gigi
- b. alergi terhadap obat-obatan, makanan dll

gejala klinik:

- c. kulit berbentuk bintik merah
- d. membentuk lapisan yang membengkak dan meradang

Rencana perawatan: konsul ke dokter umum/ dokter spesialis

4. Arthritis: radang persendian

Pengertian: suatu penyakit sistemik kronis yang ditandaidengan peradangan ringan sampai berat pada jaringan senyambung/ sendiri

Gejala klinis:

- a. rasa lelah
- b. turunnya berat badan
- c. demam
- d. nyeri sendi
- e. kekakuan di pagi hari lebih dari 30 menit sampai berjam-jam

Rencana perawatan: konsul ke dokter umum/ dokter spesialis

BAB VII

PEDOMAN PRAKTIKUM

1. Tujuan Praktikum :

Mahasiswa mampu melakukan demonstrasi dan simulasi dalam :

- a. Mengidentifikasi penyakit jaringan keras gigi dan jaringan lunak mulut dengan benar
- b. Melakukan pemeriksaan gigi dan mulut (tahap diagnose keperawatan gigi) yang benar
- c. Menentukan kelainan dirongga mulut berdasarkan gejala-gejalanya.
- d. Mengidentifikasi kelainan local dan sistemik
- e. Mengidentifikasi indikasi rujukan
- f. Mengerjakan tindakan pertolongan pada gigi dengan keluhan sakit (pulpitis, periodontal poket, periodontitis, pericoronitis)

2. Sistem Penilaian :

Sistem penilaian yang dilakukan didasarkan pada :

- a. Penilaian Input : Hasil pre test (lisan/tulisan)
- b. Penilaian Proses : Penilaian terhadap kegiatan praktek
- c. Penilaian Output : Penilaian keseluruhan proses pemeriksaan (pemuhan requirement, post test (lisan/tulisan), ujian, dll)

3. Tata Tertib Praktikum

a. Sebelum Pratikum Dimulai

- 1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktek sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan untuk masing-masing kelompok
- 2) Memakai baju seragam dan baju praktikum sesuai ketentuan
- 3) Pakaian bersih dan rapi
- 4) Mahasiswi memakai jilbab dengan les hijau
- 5) Mahasiswa rambut terpankas rapi
- 6) Memakai badge nama
- 7) Sepatu putih bagi mahasiswi dan sepatu hitam bagi mahasiswa dengan kaos kaki putih
- 8) Kuku jari pendek dan rapi
- 9) Tidak dibenarkan memakai perhiasan kecuali jam tangan
- 10) Hadir 15 menit lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan
- 11) Menandatangani presensi
- 12) Melapor ke pembimbing sebelum memulai pekerjaan dan pada setiap tahapan pekerjaan

- 13) Membawa pasien, sandal jepit, sandal jepit untuk pasien, 2 lembar handuk putih
- 14) Meminta paraf pada pembimbing pada tiap tahapan yang dilakukan.
- 15) Bagi mahasiswa yang tidak ada pasien tetap berada di klinik sampai dengan selesai praktikum

b. Saat Praktikum Berlangsung

- Peralatan yang dipakai harus dijaga keutuhannya
- Bila akan menggunakan peralatan dan baahan, harus melapor pada laboran
- Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- Tiap tahapan kerja wajib melapor kepada pembimbing

c. Setelah Praktikum Selesai

- Melapor pada pembimbing bahwa praktek telah selesai
- Mengembalikan dan memastikan kelengkapan alat-alat yang sudah dipinjam kepada coordinator praktikum
- Meminta nilai praktikum

4. Sanksi

Mahasiswa yang melanggar tata tertib diatas dikenakan sanksi sesuai dengan macam dan sifat pelanggarannya. Bentuk pelanggaran dapat berupa :

- a. Melanggar tata tertib seperti tercantum diatas
- b. Terlambat tanpa alasan yang sah

Bentuk sanksi dapat berupa :

- a. Peringatan
- b. Tidak diakui praktikum/tidak memperoleh nilai
- c. Tidak diperkenankan mengikuti UAS praktikum
- d. Bagi mahasiswa yang memalsukan tanda tangan pembimbing akan dikeluarkan nilai “E”
- e. Bagi mahasiswa yang tidak hadir sebanyak 20% akan mendapatkan nilai “E”

5. Alat-alat dan bahan yang harus disediakan oleh Mahasiswa

- a. Diagnosa set
- b. Handuk putih 2 lembar
- c. Masker
- d. Sarung tangan
- e. Alas bracket table
- f. Tempat kapas kotor
- g. Slaber pasien
- h. Kapas
- i. Alcohol

6. Prosedur Kerja Praktek Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut

a. Pengertian :

Adalah pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara menyeluruh dan teliti oleh tenaga kesehatan gigi untuk menentukan diagnosa dan rencana terapis.

b. Maksud :

- 1) Mendapatkan data kelainan-kelainan/ penyakit gigi dan mulut
- 2) Menentukan diagnosa dan menyusun rencana perawatan
- 3) Sebagai data/bahan untuk memotivasi pasien

c. Persiapan

- 1) Operator menyiapkan dirinya dengan mengenakan jas lab putih bersih, masker dan sarung tangan
- 2) Menyiapkan Kartu Status Pasien (KSP) pada meja jalan
- 3) Menyiapkan alat dan bahan

d. Cara Pemeriksaan

- 1) Pasien didudukkan didental unit dengan posisi yang benar
- 2) Pemeriksaan gigi dilakukan pada keluhan utama terlebih dahulu, lalu gigi kanan atas → gigi kiri atas → gigi kiri bawah → gigi kanan bawah.
- 3) Penulisan elemen gigi dengan metode FDI dan metode Zygmondy (masing-masing 50 % dari jumlah hari praktek)
- 4) Waktu pemeriksaan untuk setiap pasien maksimal 15 menit

7. Minimal Requirement

Minimal requirement atau minimal kasus yang harus dipenuhi mahasiswa pada akhir praktek yaitu :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) Iritasi Pulpa | : 2 kasus |
| 2) Hiperemi pulpa | : 2 kasus |
| 3) Pulpitis (ambil tindakan) | : 1 kasus |
| 4) Nekrosis Koangulasi | : 1 kasus |
| 5) Nekrosis Likuifaksi | : 1 kasus |
| 6) Periodontitis (ambil tindakan) | : 1 kasus |
| 7) Pericoroniti/operculitis | : 1 kasus |
| 8) Gingivitis | : 3 kasus/sextan |
| 9) Poket Periodontal | : 1 kasus |
| 10) Anomali Gigi | : 5 kasus |

Evaluasi:

1. Bagaimana Cara Pemeriksaan Subyektif Dan Obyekti ?
2. Apa Yang Dimaksud Dengan Anomali Gigi Serta Faktor- Faktor Penyebab?
3. Apa-Apa Saja Kelainan Jaringan Keras Gigi?

DAFTAR PUSTAKA

- Burket, L. W., 1971, *Oral Medicine, diagnosis and treatment*, J.B. Lippincott Company.
- Depkes R.I, 1996, *Oral Diagnostik*, Pusdiknakes, Jakarta.
- Grossman,L.I, Oliet, S. dan Del Rio,C.E. 1995, *Endodontic Practice*. Penerjemah: Abyono, R dan Suryo, S, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, Jakarta.
- Kerr, D. A., 1974, *Oral Diagnosis*, The CV Mosby Company, Saint Louis.
- Depkes R.I, 1992, *Oral Diagnostik*, EGC, Jakarta
- Itjiningsih, 1995, *Anatomi Gigi*, EGC, Jakarta
- Schuurs, 1993, *Patologi Gigi-Geligi : Kelainan-Kelainan Jaringan Keras Gigi* (Terj.) Gadjah Mada University Press Jogjakarta
- Sodiono, J., Kurniadhi, B., Hendrawan, A., dan Djimantoro, B., 2003, *Ilmu Patologi*, EGC, Jakarta
- Tyldesley, W.R., 1991, *Atlas Berwarna Penyakit Orofisial*, (terj.) Yuwono,L., Widya Medika, Jakarta
- Ford, T.R.Pitt (1993). *Restorasi Gigi (PP 46-47)*. Jakarta : EGC.
- Grossman, L.I. (1995). *Ilmu Endodontik dalam Praktik (PP 1-19)*. Jakarta : EGC.
- Kidd, E.A.M. (2000). *Manual Konservasi Restoratif*. Jakarta : Widya Medika.
- Danuningrat CP, 2006 : Kista odontogenik dan non odontogenik , cetakan pertama, Airlangga, Univercity Press
- Depkes, 1996, *Oral Diagnostik*, Jakarta
- Haskell R, Gayford JJ , 1990 ,Alih bahasa oleh Yuwono L, : Penyakit gigi dan mulut , EGC Anggota Ikapi, cetakan ke 3 .
- Usri K dkk, 2006 : Diagnosis dan terapi penyakit gigi dan mulut , Bandung , LSKI
- Lynch MA, Briygman VJ, Greenberg MS, 1994, *Burkets Oral medicine , Diagnosis and Treatment*, Nineth Edison, JB.Lippnicott Company, Philadelphia
- Tyldeslcy W.R ,1991,A Coloratlas of orofacial Deseases Indedition ,Wolfe Publishing Ltd
- Wilkin E.M : 2005 : Dinical Practice of the Dental Hygienisst, Nineth ed , Philadolhia.
- J.J. Pinborg, Atasi Penyakit Gigi dan Mulut, Bina Rupa Aksara, 1994.
- Haskell, R. Gayford J.J, Penyakit Mulut, Ed ke-2, EGC, 1990.

Scolly, C, Dios Pedro. Diz, Kumar, N, Special Care in Dentistry. Hand book of Oral Hea

Gawkrodger, David. J, 2004, *Human Disease for Dentists*, Blackwell, UK.

Lynch, Malcolm. A, 1994, Oral Medicine, Diagnosis and Treatment, JB. Lippincott, Philadelphia lth Care Churchill living stone, 2007

Darby ML & Walsh MW 2003, *Dental Hygiene Theory and Practice*,

Saunders, USA Wijaya I 2003, *Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut*, Jurusan Kesehatan Gigi Poltekes Bandung

Gaylor LJ 2007, *Administrative Dental Assistant*, Saunders Elsevier, USA